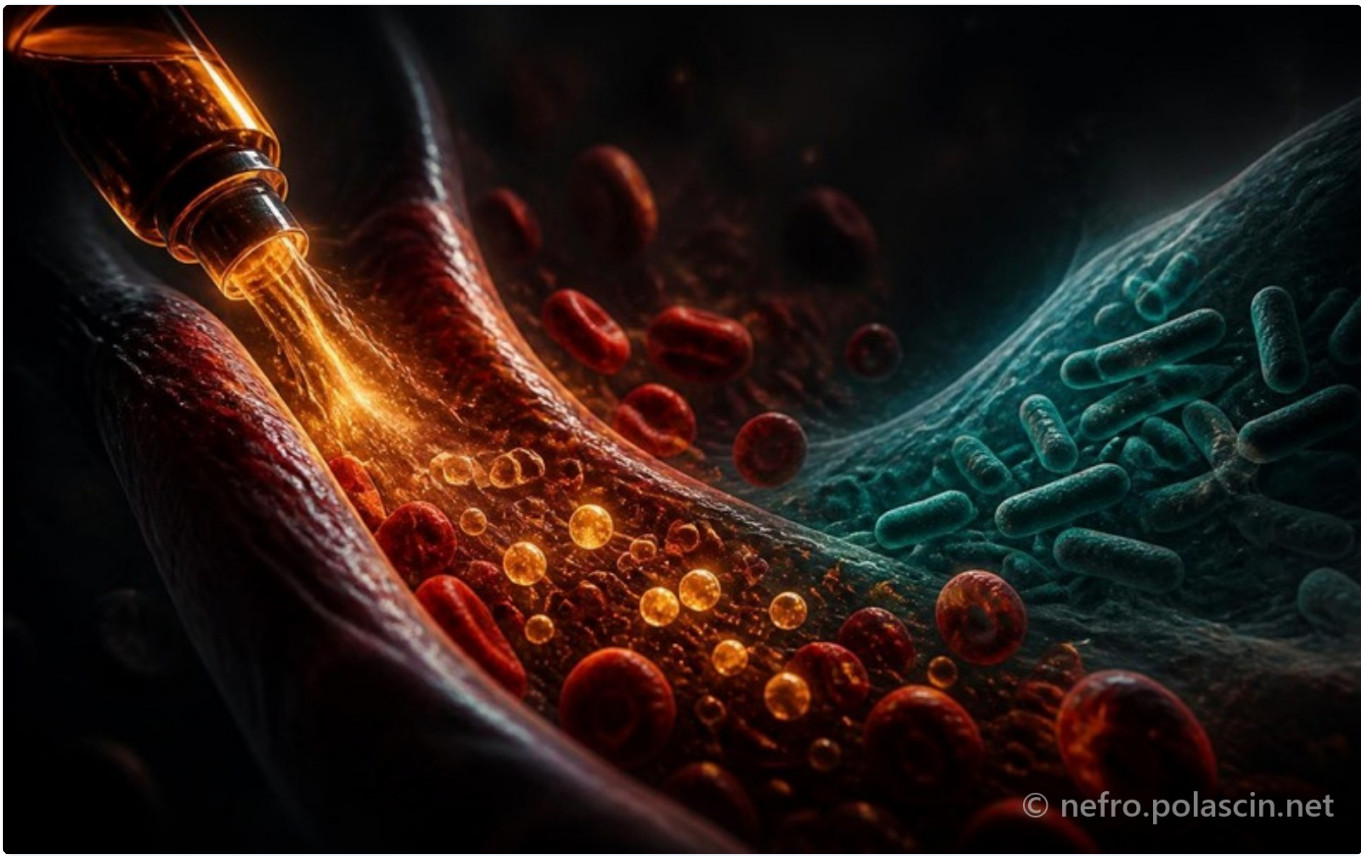
IV železo počas akútnej infekcie: reálne dáta proti strachu zo „zhoršenia infekcie"

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 22.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Obava, že železo „prikŕmi" infekciu, sa v reálnych dátach nepotvrdila.

Dlhé roky sa opakovalo pravidlo: ak má pacient akútnu infekciu, IV železo radšej nedávať. Dôvod bol intuitívny a „logický“, no klinicky problematický: železo je potrebné aj pre patogény, a preto sa dalo očakávať zhoršenie infekcie. V praxi však často narážame na opačný problém: u hospitalizovaných pacientov s deficitom železa a anémiou býva anémia zhoršujúca toleranciu infekcie, regeneráciu, funkčný stav aj potrebu transfúzií.

Nová retrospektívna „real-world“ štúdia (TriNetX) publikovaná v *Blood* prináša signál, že IV železo podané počas akútnej infekcie nespôsobuje zhoršenie infekcie a môže byť spojené s lepšími výsledkami.

Prečo bola táto otázka dôležitá aj pre nefrológiu

V nefrologickej starostlivosti (CKD, hemodialýza, akútne hospitalizácie) sa deficit železa často prekryje s infekciou. Vtedy vzniká dilema:

- anémia zhoršuje priebeh a hospitalizačné výsledky,
- ale obavy z rizika infekčného „flare“ po podaní železa sú stále silné,
- navyše nie každému sa dá bezpečne a rýchlo pomôcť perorálnym železom.

Štúdia sa teda netvárila ako teória, ale chcela zodpovedať praktickú otázku: čo sa deje s pacientmi, keď IV železo reálne podávame počas akútnej infekcie?

Čo štúdia robila (dizajn a cieľ)

Ide o retrospektívnu kohortovú štúdiu v reálnej praxi využívajúcu sieť TriNetX (obdobie rokov 2000 až jún 2025). Cieľom bolo zhodnotiť bezpečnosť a účinnosť IV železa u hospitalizovaných dospelých s anémiou z nedostatku železa (IDA) počas akútnej infekcie, s dôrazom na:

- infekčné a „hard“ klinické outcome,
- hospitalizačné využitie (napr. dĺžka hospitalizácie),
- potrebu transfúzií,
- hematologické výsledky (napr. obnova hemoglobínu).

Hlavné výsledky: IV železo bez signálu zhoršenia infekcie

Zhrnutie z dostupných materiálov k štúdii je konzistentné v jednom bode: IV železo podané pri akútnej infekcii **sa nespojilo so zhoršením infekcie**.

Štúdia navyše uvádza, že IV železo bolo asociované s lepšími výsledkami, konkrétne najmä:

- **lepšou obnovou hemoglobínu** po liečbe,
- **bez nárastu dĺžky hospitalizácie**,
- **menším výskytom dní, keď pacient dostával transfúzie** (teda menej transfúznej záťaže),
- a v širšom hodnotení tiež so **zlepšením klinických outcome** vrátane prežívania.

Poznámka k presnosti: v dostupných materiáloch nie sú uvedené konkrétne percentá a absolútne rozdiely. Pri publikovaní detailov je vhodné pozrieť primárny článok alebo tabuľky v práci, ak chcete uvádzať čísla do praxe.

Čo si z toho zobrať pre prax nefrológa

Ak ste doteraz zvažovali „nechať pacienta prežiť infekciu a až potom riešiť deficit železa“, táto štúdia podporuje realistickejší prístup: u hospitalizovaných pacientov s IDA a akútnou infekciou môže byť IV železo rozumné, pretože:

1. **nevidíme jasný signál, že by infekciu zhoršovalo**,
2. **hemoglobín ide nahor**,
3. **transfúzie môžu byť menej potrebné**.

V praxi to pre vás znamená prehodnotiť miestne zvyky a indikačné bariéry. Dôležité však je držať sa klinickej logiky: nepozeráme len na „vhodnosť počas infekcie“, ale aj na to, či má pacient reálny deficit železa, či nejde o situáciu s iným dominantným zdrojom anémie (napr. výrazná supresia kostnej drene alebo iná etiológia).

Limity: je to retrospektíva, nie randomizácia

Pri každej retrospektívnej analýze je potrebné mať na pamäti, že ide o asociácie, nie o kauzalitu. Aj keď použitie veľkej databázy a porovnávacích metód znižuje skreslenie, stále existuje možnosť, že pacienti, ktorým IV železo dali, boli v niektorých ohľadoch „iní“ (napr. dostupnosť liečby, závažnosť anémie, lokálne postupy, časovanie intervencie).

Napriek tomu ide o typ dôkazov, ktorý v klinike často rozhoduje: real-world data, ktoré priamo adresujú problém, na ktorý sa v praxi naráža každý týždeň.

Záver v 30 sekundách

U hospitalizovaných dospelých s anémiou z nedostatku železa pri akútnej infekcii sa IV železo v reálnej praxi **nespojilo so zhoršením infekcie** a bolo asociované s **lepšou hematologickou odpoveďou** a **menšou transfúznou záťažou**, bez zjavného zhoršenia hospitalizačného využitia. Stále platí, že ide o retrospektívne dáta a detaily treba overiť v primárnej publikácii, ale praktický odkaz je jasný: obavy z „urýchlenia infekcie“ nemusia byť dôvodom na systematické odkladanie IV železa.

Zdroj: *Medscape Education (CME/CE) aktivita k publikácii v Blood: „A Retrospective, Real-World Study of IV Iron Use to Treat Iron Deficiency Anemia During Acute Infection“. Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=iv-zelzo-pocas-akutnej-infekcie-realne-data · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.